

Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України

Накази МОУ:
№ 518 та №544, № 543



Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації

Поширення дії наказу на військовослужбовців ДССЗІ

На виконання ПКМУ “Деякі питання проведення військово-лікарської експертизи в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації” від 25 червня 2025 року № 759.

Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затверджене наказом Міністерства оборони від 14 серпня 2008 р. № 402, **поширюється на ДССЗІ.**

Для кого:

військовослужбовці ДССЗІ та члени їх сімей;

громадяни, які добровільно вступають на військову службу (навчання) за контрактом у ДССЗІ;

особи, звільнені з військової служби в ДССЗІ;

проводять ВЛК в ЗОЗ ДССЗІ, МОУ та МВС, ЗОЗ комунальної та державної форми власності.

Зміни внесено до: пунктів 1.1 та 1.3 глави 1 розділу І; підпункту 2.3.3 пункту 2.3 та підпункту 2.4.5 пункту 2.4 глави 2 розділу І; пункту 1.1 глави 1 розділу ІІ; пункту 6.1 глави 6 розділу ІІ, змінений заголовок глави 21 розділу ІІ.



Медичний огляд

Належний медогляд та документальний слід

Було	Стало
Основний медогляд 4 дні	Основний медогляд 6 днів
Додаткові дослідження: лабораторні та інструментальні.	Додаткові дослідження: лабораторні та інструментальні, інші обстеження (зокрема комплексні в стаціонарі)
Під час дії правового режиму воєнного стану військовозобов'язаним перед медичним оглядом проводилось: • рентгенологічне обстеження органів грудної клітки; • ЕКГ виконувалось після досягнення 40-річного віку та за наявності медичних показань; • Інші дослідження виконувались за показаннями.	В процесі медичного огляду обов'язково проводяться: • загальний аналіз крові; • загальний аналіз сечі; • серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ); • поверхневий антиген до вірусу гепатиту «В» (HbsAg); • загальні антитіла до вірусу гепатиту «С» (anti-HCV); • реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном або загальні антитіла до блідої трепонеми (RW); • визначається група крові та резус-належність; • рентгенологічне обстеження органів грудної клітки; • ЕКГ. Особам старшим 40 років проводиться вимір внутрішньоочного тиску, дослідження крові на цукор. Інші дослідження проводяться за показаннями.



Статті придатності

Мінімізація допуску дефакто непридатних нарко- та алкозалежних

Було	Стало
Додаток 1 стаття 15 пункт “а”	
а) при синдромі залежності з тяжкими, стійкими психічними розладами;	а) при синдромі залежності з активним вживанням та тяжкими, стійкими психічними розладами;
Додаток 2 стаття 15 пункт “а”	
Дуже коротко: психічні і поведінкові розлади, зумовлені зловживанням психоактивних речовин з активною залежністю. Характерні різко виражені зміни особистості з інтелектуально-мнестичними і психотичними порушеннями, з відсутністю позитивного ставлення до лікування та критики до свого стану.	Тяжкі психічні розлади, зумовлені зловживанням психоактивних речовин з активною залежністю, а саме: розлади психічної діяльності (затьмарення свідомості, порушення сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам’яті), які позбавляють особу здатності адекватно усвідомлювати оточуючу дійсність, свій психічний стан і поведінку. Категорія залежних: • з психічними та поведінковими розладами, різко вираженими змінами особистості з інтелектуально-мнестичними і психотичними порушеннями; • знаходяться на державній програмі замісної підтримуючої терапії; • та/або з анамнезом стаціонарного лікування більше 3 років, • змінами в органах-мішенях, що підтверджується результатами інструментальних методів дослідження та змінами лабораторних показників: ГГТП та АЛТ/АСТ більше ніж в 5 разів вище норми. Якщо виявлені ознаки розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин - направлення на консультацію до лікаря нарколога та/або стаціонарне обстеження - встановлення ступеня залежності - токсикологічне дослідження.



Статті придатності

Визначення тих, хто зможе виконувати завдання в підрозділах забезпечення

Було	Стало
Додаток 1 стаття 15 пункт “б”	
б) при синдромі залежності з помірними або легкими психічними розладами	б) згубне вживання (вживання речовин, пов’язане зі шкодою для здоров’я)
Додаток 2 стаття 15 пункт “б”	
Психічні та поведінкові розлади, зумовлені зловживанням психоактивними речовинами, при синдромі залежності з помірними або незначними психічними розладами та збереження критичного ставлення до свого стану і поведінки. Поодиноке або епізодичне вживання психоактивних речовин або інших токсичних речовин без психічних та соматичних розладів не може бути підставою для застосування цієї статті.	Психічні та поведінкові розлади, зумовлені згубним вживанням психоактивних речовин, з психічними розладами за відсутності стійкої компульсивної тяги, абстиненції та зміни толерантності до психоактивних речовин при збереженні критичного ставлення до свого стану і поведінки. Тимчасові психотичні розлади, делірій, що виникли на фоні вживання психоактивних речовин або інших токсичних речовин, які добре піддаються лікуванню з виходом в одужання, компенсацію або астенію не можуть бути підставою для застосування цієї статті. Поодиноке або епізодичне вживання психоактивних речовин або інших токсичних речовин без психічних та соматичних розладів не може бути підставою для застосування цієї статті.



Статті придатності

Уточнення та доповнення

Було	Стало
Додаток 1 стаття 17	
	Додано дисоціативні (конверсійні) розлади
Додаток 1 стаття 17 пункт “а” (непридатні до військової служби)	
При виражених, стійких психічних розладах з прогредієнтним перебігом	При різко виражених, стійких психічних розладах з прогредієнтним перебігом
Додаток 2 стаття 17 пункт “а”	
Відсутня норма	При наявності психотичної симптоматики чи суїцидальної спроби в структурі невротичного розладу – винесення експертного рішення не залежить від тривалості хворобливих проявів.



Статті придатності

Уточнення та доповнення

Було	Стало
Додаток 1 стаття 17 пункт “б” (придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони)	
При помірно виражених, тривалих або повторних психічних розладах	при стійких помірно виражених тривалих або повторних психічних розладах, зі стабільним типом перебігу .
Додаток 2 стаття 17 пункт “б”	
Експертна постанова приймається після безуспішного стаціонарного лікування хворого не менше двадцяти одного дня.	Експертна постанова приймається після проходження трьох курсів стаціонарного лікування в спеціалізованих закладах охорони здоров'я тривалістю не менше двадцяти одного дня протягом дванадцяти місяців .



Статті придатності

Уточнення та доповнення

Було	Стало
Додаток 1 стаття 17 пункт “в” (придатні)	
При легких психічних розладах з виходом в одужання	При помірно виражених чи легких психічних розладах, які добре піддаються лікуванню
Додаток 2 стаття 17 пункт “в”	
Помірно виражені, короткотривалі (до трьох тижнів) невротичні розлади із сприятливим перебігом, ПТСР з регредієнтним типом перебігу, помірний депресивний епізод із сприятливим перебігом.	Помірно виражені, легкі, короткотривалі невротичні розлади із сприятливим перебігом, ПТСР з регредієнтним типом перебігу, помірний депресивний епізод із сприятливим перебігом, які добре піддаються лікуванню.



Статті придатності

Уточнення та доповнення

Було	Стало
Додаток 1 стаття 17 пункт “г” (Тимчасово непридатні. Потребують лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків)	
Стан після первинних гострих невротичних порушень; адаптаційні розлади; ПТСР після епізоду загострення; легкі невротичні розлади, які добре піддаються лікуванню та закінчуються одужанням	Стан після первинних гострих невротичних порушень; адаптаційні розлади; ПТСР після епізоду загострення, що потребують тривалого лікування та реабілітації; легкі невротичні розлади, які добре піддаються лікуванню з виходом в компенсацію або астенію
Додаток 2 стаття 17 пункт “г”	
Стани після: • первинних гострих невротичних порушень; адаптаційні розлади; • ПТСР після епізоду загострення, які потребують лікування, реабілітації, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків. При легких невротичних розладах, які добре піддаються лікуванню та закінчуються одужанням, приймається постанова «Придатний до військової служби.	Стани після: • первинних гострих невротичних порушень; ПТСР після епізоду загострення, що потребують тривалого лікування та реабілітації; • депресивний епізод після загострення із сприятливим перебігом, адаптаційні розлади; • легкі невротичні розлади, які добре піддаються лікуванню з виходом в компенсацію або астенію, які потребують лікування, реабілітації, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків. У разі встановлення попереднього діагнозу «Дисоціативні (конверсійні) розлади» пацієнт підлягає поглибленому медичному огляду суміжних спеціалістів для виключення соматичної патології.



Статті придатності

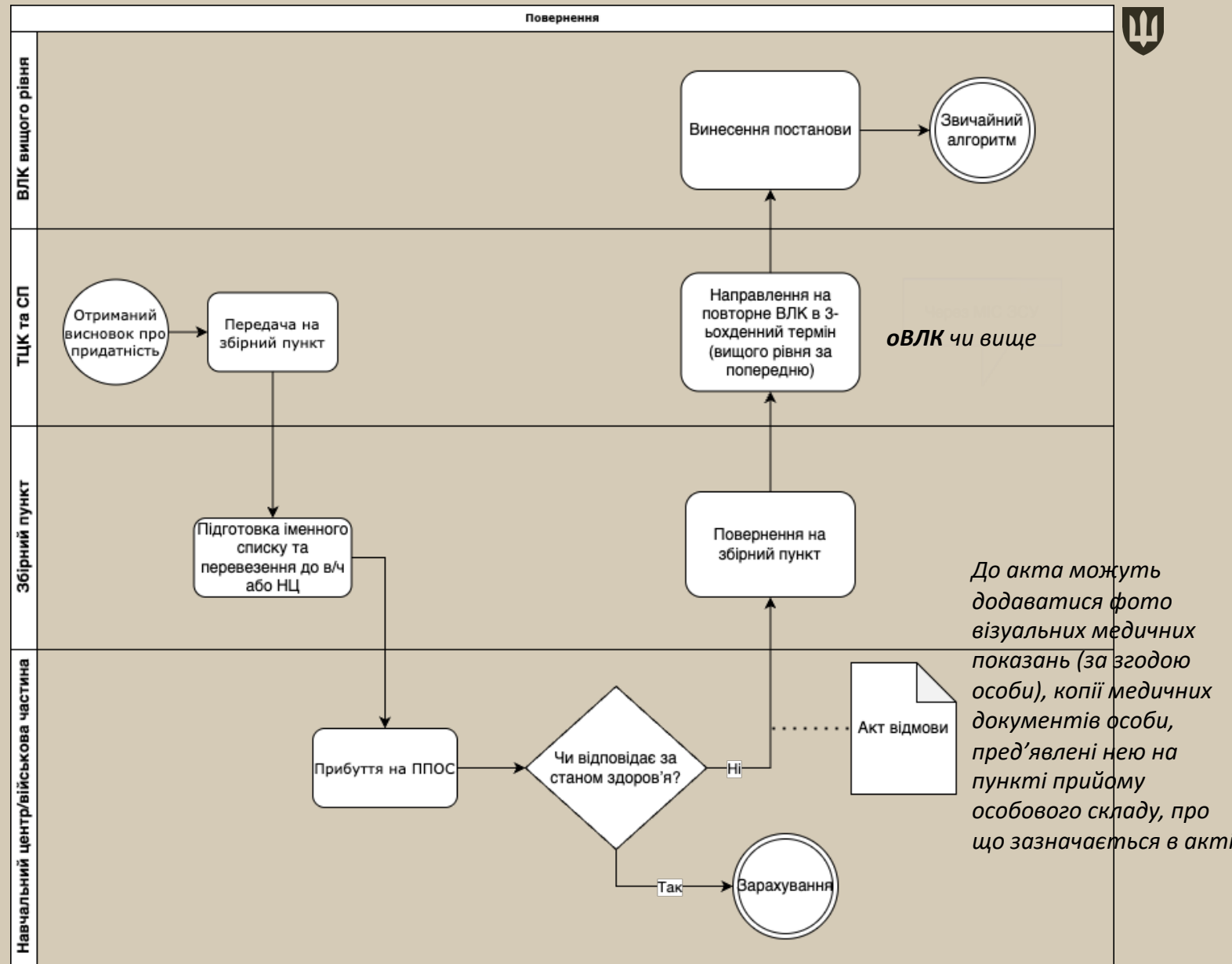
Уточнення

Було	Стало
Додаток 2 стаття 19 пункт “а”	
Тяжка або помірна розумова відсталість або легка зі значними поведінковими порушеннями, що потребують уваги або лікування. При значних та явних дефектах інтелекту питання про непридатність до військової служби може бути вирішене і без госпіталізації у спеціалізований заклад охорони здоров’я (установу).	Тяжка або помірна розумова відсталість зі значними поведінковими порушеннями, що потребують уваги або лікування. При значних та явних дефектах інтелекту питання про непридатність до військової служби може бути вирішене і без госпіталізації у спеціалізований заклад охорони здоров’я (установу).

Легкий ступінь відноситься до пункту ”б”

Повторні медичні огляди у разі відмов в зарахуванні

MP



Причинні зв'язки

Було	Стало
Не було врегульовано встановлення причинного зв'язку захворювань та поранень (контузій, травм, каліцтв) у осіб, які перебували в полоні.	Захворювання та поранення (контузії, травми, каліцтва), які виникли у осіб в період перебування в місцях несвободи, або загострені хронічні захворювання можуть бути пов'язані із захистом Батьківщини, у разі встановлення факту позбавлення особистої свободи державою-агресором, її органами, підрозділами, формуваннями, іншими утвореннями у зв'язку із захистом державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності і недоторканності України внаслідок збройної агресії проти України.
Довідка про обставини травми була можливістю...	АЛЕ уточнили, що одною з обставин може бути перебування в місцях несвободи (у разі встановлення факту позбавлення особистої свободи державою-агресором, її органами, підрозділами, формуваннями, іншими утвореннями у зв'язку із захистом державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності і недоторканності України внаслідок збройної агресії проти України)



Направлення на ОПФО

Було	Стало
Голови ВЛК формують електронне направлення осіб на проведення ОПФО	Голови ВЛК зобов'язані формувати електронне направлення осіб на проведення ОПФО!!!



Міністерство
оборони України

Дякуємо за увагу!
